

ACTA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE CONSULTORIO PSICOLÓGICO

ACTA DE REUNIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

Prestador de Servicios de Salud:	
NIT / Documento:	
Código de Habilitación:	[Código si aplica]
Fecha:	___ / ___ / 2026
Hora de inicio:	_____ Hora de finalización: _____
Lugar:	Manizales, Caldas
Responsable de la reunión:	Gladys eugenia Quintero C (Asesor SG-SST) / [Responsable Clínica]

OBJETIVO

Socializar y fortalecer las actividades encaminadas a la promoción de la Seguridad del Paciente, orientadas a prevenir incidentes y eventos adversos, fortalecer la cultura de seguridad y garantizar una atención segura, humanizada, confidencial y de calidad en la prestación de servicios de psicología.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistencia.
2. Presentación del objetivo de la reunión.
3. Socialización de la Política de Seguridad del Paciente institucional.
4. Revisión de prácticas seguras implementadas en consulta psicológica.
5. Identificación de riesgos asistenciales (físicos y de confidencialidad).
6. Revisión de incidentes o eventos adversos reportados.
7. Definición de acciones de mejora.
8. Compromisos y Cierre.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la reunión se socializaron las políticas institucionales de Seguridad del Paciente, enfatizando la importancia de desarrollar una cultura preventiva basada en la identificación temprana de riesgos y el aprendizaje continuo, aplicadas al contexto de la salud mental.

Se revisaron las siguientes prácticas seguras aplicables al consultorio psicológico:

- Identificación correcta del paciente antes de iniciar la consulta.
- Garantía de confidencialidad, privacidad y secreto profesional (Ley 1090 de 2006).
- Obtención y verificación del consentimiento informado (y asentimiento para menores de edad).
- Diligenciamiento oportuno, claro y completo de la historia clínica psicológica.
- Custodia segura de las historias clínicas y pruebas psicotécnicas (manejo de claves y archivos bajo llave).
- Rutas de derivación y manejo de urgencias (ideación suicida, crisis aguda, agitación psicomotora).
- Prevención de caídas en el consultorio (seguridad locativa básica).
- Higiene de manos y medidas básicas de bioseguridad.
- Reporte oportuno de incidentes y eventos adversos (ej. vulneración de datos, caídas, errores de identificación).
- Implementación de acciones preventivas para evitar la repetición de eventos.

Se recordó que el reporte de incidentes tiene un carácter preventivo y educativo, promoviendo una cultura justa y de mejoramiento continuo, sin carácter punitivo.

ACTIVIDADES REALIZADAS (Checklist)

Actividad	Sí (X)	No (X)
Socialización de Política		
Revisión Prácticas seguras		
Protocolo de Identificación del paciente		
Gestión de Incidentes		
Identificación de Riesgos		
Acciones de Mejora		

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite

CONCLUSIONES

Se concluye que las actividades desarrolladas fortalecen la cultura de Seguridad del Paciente, disminuyen el riesgo de eventos adversos (especialmente los relacionados con la gestión de la información clínica y crisis de pacientes) y promueven una atención segura y de calidad. Se acuerda continuar con las actividades de capacitación, seguimiento y mejoramiento continuo.

FIRMAS DE ASISTENCIA

[illegible]